

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Consent Information - Patient Copy Abdominoperineal Resection of Rectum

معلومات الإقرار - نسخة المريض الاستئصال البطني العجاني للمستقيم (الدبر)

PLEASE READ THIS SHEET BEFORE YOU CONSENT TO YOUR SURGERY

This information sheet provides general information to a person having bowel cancer surgery. It does not provide advice to the individual. It is important that you talk about this with your Doctor who understands your level of fitness and your medical condition.

1. What do I need to know about this condition?

The large bowel (intestine) is made up of the colon and rectum (back passage). This part of the digestive tract carries the remains of digested food from the small bowel and gets rid of it as waste through the opening to the back passage (anus). Cells that line the colon and rectum may begin to grow out of control, forming a tumour (a growth of cancer cells).

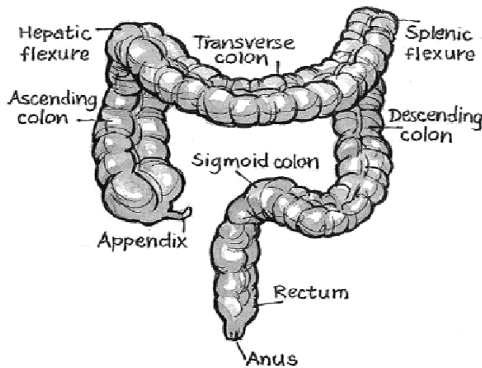
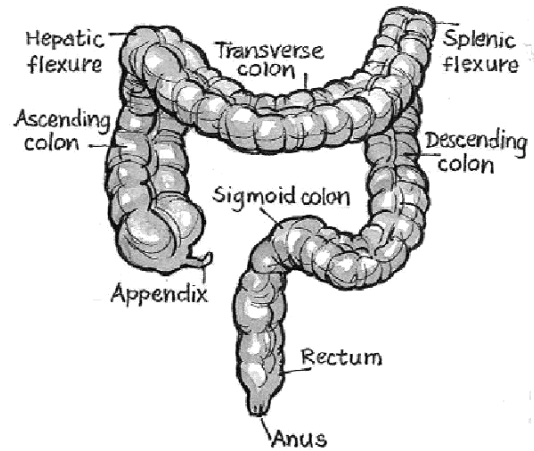


Diagram showing the parts of the bowel

The bowel has four sections: the ascending colon, the transverse colon, the descending colon and the sigmoid colon. Tumours can start in any of these

نرجو منك قراءة هذه الورقة قبل التوقيع بالموافقة على إجراء جراحتك
تعطي ورقة المعلومات هذه معلومات للشخص الذي سيخضع لجراحة استئصال سرطان في الأمعاء . لا تعتبر ورقة المعلومات هذه بمثابة النصيحة للمريض . من المهم قيامك بمناقشة ذلك مع طبيبك الذي يدرك حالتك الطبية ومدى ملائمتك صحياً.

1. ما الذي ينبغي لي معرفته عن هذه الحالة الطبية؟
تتكون الأمعاء الغليظة من القولون (الجزء الأسفل من الأمعاء الغليظة) والمستقيم (الدبر). هذا الجزء من الجهاز الهضمي يقوم بنقل بقايا الغذاء المهضوم من الأمعاء الدقيقة ويتخلص من فضلاتها عبر الدبر (فتحة الشرج).
قد تبدأ الخلايا المبطنة للقولون والمستقيم بالنمو بشكل خارج عن السيطرة مكونةً ورماً خبيثاً (نمو الخلايا السرطانية).



تتكون الأمعاء من أربعة أقسام :
القولون التصاعدي ، القولون المستعرض ، القولون التنازلي والقولون السيني (يشبه حرف S). قد يبدأ الورم من أي من هذه الأقسام أو من الدبر . يمكن للورم أن يبدأ من الطبقة

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

areas or in the back passage. Tumours start in the innermost layer and can grow through some or all of the other layers.

2. What do I need to know about the procedure?

Surgery is the main treatment for tumours of the bowel. Usually, the tumour and a length of normal bowel on either side of the tumour (as well as nearby lymph nodes) are removed. The healthy parts of the bowel are then stitched or stapled together (anastomosis).

If the doctor is not able to join the bowel back together, an opening (stoma) will be made on the outside of the body for waste to pass out of the body.

This is called a colostomy. A colostomy is made to allow waste to pass through an opening in the abdominal wall.

Sometimes, a temporary colostomy is needed until the joined bowel has healed, and then it can be put back. This is done by further surgery. However, in some cases, the colostomy is permanent, which means it can never be put back, and there will always be an opening on the skin for bowel waste to pass through.

A number of different surgical procedures are used depending on where the tumour is. These include:

- ☐ **Right Hemicolectomy:** Removal of the last part of the small bowel, the caecum, ascending colon and a small part of the transverse colon
- ☐ **Left Hemicolectomy:** Removal of the descending colon and sigmoid colon.
- ☐ **Sigmoid Colectomy:** Removal of the sigmoid colon and nearby large bowel.

A number of different surgical procedures are available to treat tumours of the back passage, the choice depending on where the tumour is

الداخلية ، ويمكنه بعد ذلك أن ينمو إلى بعض أو كل الطبقات الأخرى.

2. ما الذي ينبغي علي معرفته بخصوص هذا الإجراء؟

الجراحة هي العلاج الرئيسي لأورام الأمعاء. يتم استئصال الورم وجزء من الأمعاء السليمة التي تسبق الورم ، وجزء آخر من الأمعاء السليمة التي تعقب الورم ، كما تتم إزالة العقد الليمفاوية المجاورة. يتم بعد ذلك ربط وخياطة أو تدبيس الأمعاء السليمة على جانبي الجزء المستأصل (التقمم أو المفاغرة).

إذا لم يتمكن الجراح من ربط جزئي القولون مع بعضهما البعض ، يتم عمل فتحة (تغير) متصلة بخارج الجسم لإخراج الفضلات خارج الجسم.

تسمى هذه الفتحة (فغر القولون) ، وتهدف للسماح للفضلات بالخروج عبر فتحة في جدار البطن.

أحياناً تكون الحاجة لهذه الفتحة مؤقتة لحين التئام جانبي الأمعاء الذي تم وصلهما معاً ثم تتم إعادتها بعد ذلك ، ويتم ذلك بعملية أخرى . إلا أنه وفي بعض الحالات تكون هذه الفتحة دائمة مما يعني أنه لا يمكن إعادتها وستكون هناك على الدوام فتحة من الجلد تخرج من خلالها فضلات الأمعاء.

توجد أنواع متعددة من الجراحات التي يمكن القيام بها ، ويعتمد ذلك على موقع الورم ، ومن هذه الجراحات:

- ☐ **استئصال نصف القولون الأيمن:** إزالة الجزء الأخير من الأمعاء الدقيقة ، المصران الأعور ، القولون التصاعدي وجزء صغير من القولون المستعرض.
- ☐ **استئصال نصف القولون الأيسر:** إزالة القولون التنازلي والقولون السيني.
- ☐ **استئصال القولون السيني:** إزالة القولون السيني والجزء المجاور من الأمعاء الغليظة.

يتوفر عدد من الإجراءات الجراحية لعلاج أورام الدبر ويتوقف الاختيار بينها على موقع الورم ومدى انتشاره.

Patient's Name : _____

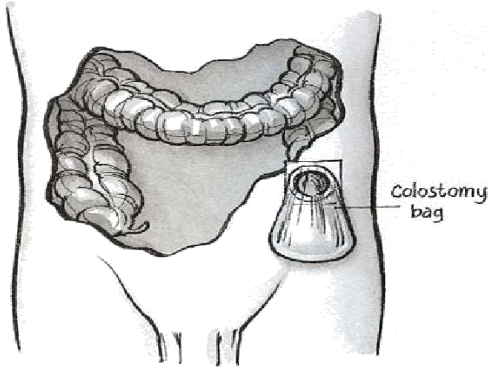
MRN : _____

DoB: _____

and how far it has spread:

- ☐ **Low Anterior Resection:** Used for most tumours of the back passage, except when the tumour is very close to the anal muscles (sphincter). The bowel and the back passage are joined together so that the back passage is spared.
- ☐ **Abdomino-Perineal Resection:** This is done when the tumour is in the lowest part of the back passage. The back passage and the opening to the back passage are removed and the area is stitched up and will remain permanently closed.

The waste collects in a disposable bag (a colostomy bag) which is stuck over the opening.



A cut-away picture showing a colostomy

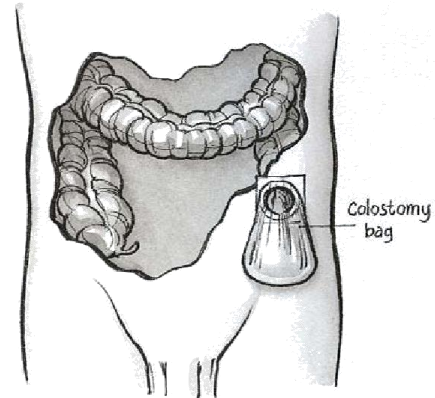
3. What do I need to do to prepare for this procedure?

Before surgery, the bowel must be prepared to lower the risk of infection. You may be told to have a low fibre diet 2-3 days before surgery. You will be then be on a clear fluid diet and given a medicated drink to help clean the large bowel. This can cause diarrhoea and cramps, and may be tiring.

☐ **الاستئصال الأمامي المنخفض:** يستخدم لعلاج معظم أورام الدبر باستثناء أن يكون الورم قريباً جداً من عضلات الشرج (العضلات العاصرة). يتم ربط الأمعاء بالدبر بحيث يتم الحفاظ على الدبر.

☐ **الاستئصال البطني العجاني:** يتم اللجوء إليه إذا كان الورم في الجزء السفلي من الدبر. يتم استئصال الدبر والفتحة المؤدية إليه وتتم خياطة المنطقة وتظل مغلقة على الدوام.

يتم جمع الفضلات في كيس يستخدم لمرة واحدة ويتم تغييره بشكل مستمر (كيس فغر القولون). يكون هذا الكيس ملتصقاً فوق فتحة الإخراج.



3. ما الذي ينبغي عليّ فعله للتحضير لهذا الإجراء ؟

يجب تحضير الأمعاء قبل الجراحة للتقليل من مخاطر العدوى. قد يطلب منك تناول غذاء منخفض الألياف ليومين أو ثلاثة قبل إجراء العملية. بعد ذلك ستوضع نظام غذائي قائم على السوائل الخالية من الشوائب وتعطى مشروب علاجي يساعد على إفراغ الأمعاء الغليظة. قد يسبب ذلك إسهالاً وتقلصات ، وقد يسبب لك التعب. سيفرغ المشروب العلاجي أمعائك بشكل كلي. تقوم بعد ذلك بالصيام لـ 6-8 ساعات على الأقل قبل إجراء الجراحة.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

The medicated drink will completely empty your bowel. You will then fast for at least 6-8 hours before your surgery. If you are having a colostomy, the surgeon or a stoma nurse will discuss with you the best site for your colostomy and will mark the area with a marker pen. It is usually placed below your belt line, away from any other scars you may have and at least 8 - 10 cm away from your wound, depending on your size and shape.

4. My anaesthetic

This procedure will require an anaesthetic.

See **About Your Anaesthetic information sheet +/- Epidural and Spinal Anaesthetic information sheet** for information about the anaesthetic and the risks involved. If you have any concerns, discuss these with your doctor.

If you have not been given an information sheet, please ask for one.

5. What are the benefits of having the procedure?

Removal of the diseased bowel is the first treatment for a tumour of the bowel. The goal of the surgery is to give you the best chance of cure through total removal of the tumour.

However, your recovery depends how far the disease has spread at the time of your operation. Surgery can also be used as a measure to ease symptoms.

6. What are the risks of not having the procedure?

Symptoms including pain and bleeding may become worse and your bowel may completely block or burst. Without surgery, the disease may spread to other areas of your body.

7. What are the alternative treatments?

Radiation Therapy has been used for some people as the main treatment for rectal tumours but is not normally used in colon tumours.

إذا كان سيوضع لك كيس فغر القولون، سيقوم الجراح أو الممرضة المختصة بهذا الأمر بالمناقشة معك حول الموضع الذي ترغب أن يكون فيه الكيس بعد العملية ، وستقوم الممرضة بوضع علامة بالقلم على الموضع المناسب لك. من المعتاد أن يوضع الكيس في مستوى تحت خط الحزام بعيداً عن أي ندوب موجودة ، وعلى بعد لا يقل عن 8-10 سنتيمتر عن موضع الجراحة ، ويتوقف ذلك على هيئتك وحجمك.

4. التخدير الذي أتلقاه

يتطلب الإجراء الخضوع للتخدير .
اقرأ تعليمات التخدير الموضعي والأدوية المسكنة المتعلقة بالإجراء الطبي المقرر لك للمزيد من المعلومات عن نوع التخدير والمخاطر المترتبة. إن كان لديك أي مخاوف أو تساؤلات قم بمناقشتها مع طبيبك المعالج.
إذا لم تقدم لك ورقة التعليمات ، نرجو عدم التردد في طلبها.

5. ما هي فوائد الخضوع للإجراء؟

إن استئصال جزء القولون المريض هو العلاج الأول لورم الأمعاء . إن الهدف من الجراحة هو منحك أكبر فرصة ممكنة للشفاء بالاستئصال الكامل للورم . إلا أن شفاؤك معتمد على مدى انتشار المرض وقت إجراء العملية. قد تستخدم الجراحة أيضاً كوسيلة لتخفيف الأعراض.

6. ما هي مخاطر عدم الخضوع للإجراء؟

قد تزداد الأعراض سوءاً كالآلم والنزيف ، وقد يحدث انسداد كامل في أمعائك أو قد تنفجر. عدم الخضوع للجراحة قد يجعل الورم ينتشر لأجزاء أخرى من جسدك.

7. ما هي وسائل العلاج البديلة؟

عند بعض المرضى ، تم استخدام العلاج الإشعاعي كوسيلة العلاج الرئيسية لأورام المستقيم ، ولكنه لا يستخدم عادةً في أورام القولون.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Radiation therapy is not as effective as surgery for patients who could normally be treated by bowel removal.

Chemotherapy (use of drugs to treat tumour) is usually used together with surgical removal and may not be offered as the only treatment

8. What are the general risks of having a procedure?

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following.

General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return to the operating room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Asprin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).
- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.
- Increased risk in obese people of wound infection, chest infection, heart and lung complications, and thrombosis.
- Heart attack or stroke could occur due to the strain on the heart.
- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and swelling. In rare cases part of the clot may break off and go to the lungs.
- Death as a result of this procedure is possible.

For specific risks of this procedure please refer to the tables on pages 3 & 4 of this information sheet.

العلاج الإشعاعي ليس بمستوى كفاءة الجراحة لدى المرضى الذين يمكن علاجهم عادةً باستئصال الأمعاء.
العلاج الكيميائي (علاج الأورام بالأدوية) يستخدم عادةً مصحوباً بالجراحة ، و قد لا يتم تقديمه كعلاج وحيد.

8. ما هي المخاطر العامة للقيام بهذا الإجراء؟ لهذا الإجراء مخاطر ومضاعفات ، وهي تشمل ، ولكنها غير مقتصرة على :

مخاطر عامة:

- قد تحدث عدوى ، مما يتطلب العلاج بالمضادات الحيوية وعلاجات أخرى
- حدوث نزيف مما قد يتطلب إعادتك مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً إذا كنت ممن يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافيكس أو اسكوفير) أو عقار دايبيير دامول (بيرسانتن أو اساسانتين)
- انهيار (انطباع) لأجزاء صغيرة من الرئة ، مما يزيد مخاطر الإصابة بعدوى الصدر ، وقد يتطلب المعالجة بالمضادات الحيوية والعلاج الطبيعي للصدر.
- عند أصحاب الأوزان الزائدة ، تزداد مخاطر الإصابة بعدوى والتهابات الجرح والصدر ، ومضاعفات في القلب والرئة ، وانسداد الأوعية الدموية.
- قد يسبب الإجهاد الواقع على القلب إلى حدوث أزمة قلبية أو سكتة دماغية.
- تخثر دموي في أحد أوردة الساق العميقة تسبب الألم والتورم في الساق . في حالات نادرة قد تنفصل أجزاء من هذا التخثر وتصل إلى الرئة.
- يوجد احتمال للوفاة بسبب هذا الإجراء
للمخاطر المحددة المرتبطة بهذا الإجراء ، يرجى مراجعة الجداول في الصفحات 3 & 4 من هذه التعليمات.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

9. What are the specific risks of this procedure

9. ماهي المخاطر المحددة المرتبطة بهذا الإجراء ؟

The Risk	What Happens	What can be done about it
الخطر	ماذا يحدث	ما يمكن القيام به حيال ذلك
Leakage of bowel fluid inside the abdomen تسرب سوائل الأمعاء إلى البطن	Leakage of bowel fluid at the site where the bowel was stitched or stapled back together. The rate of risk is about 1 in 22 to 1 in 20. تسرب سوائل الأمعاء في مكان إعادة خياطة أو تدبيس الأمعاء مع بعضها البعض. نسبة الخطر من 1 في كل 22 إلى 1 في كل 20	Further surgery may be required. قد تكون هناك حاجة لجراحة أخرى
Ileus شلل الأمعاء	The bowel is paralysed leading to abdominal bloating, and vomiting. The rate of risk is about 2 in 100. حدوث شلل في حركة الأمعاء مسببة انتفاخ في البطن واستقراغ نسبة الخطر 2 في كل 100	Treatment is to deflate the bowel with suction, using a tube (nasogastric tube) put up the nose, down the back of the throat and into the stomach or bowel. العلاج هو تفريغ الأمعاء بواسطة أنبوب (أنبوب أنفي معدي) يمرر الأنبوب من الأنف ويمر من خلف الحلق ليدخل في المعدة أو الأمعاء
Wound Infection عدوى الجرح	The wound may become infected. The rate of risk is about 1 in 9. قد يصاب الجرح بالعدوى نسبة الخطر 1 من كل 9	This may be treated with antibiotics. These may be given by a drip into a vein or by mouth. The wound may need to be opened to drain. قد يعالج بالمضادات الحيوية التي قد تعطى بمحقنة في الوريد أو عن طريق الفم. قد تكون هناك حاجة لفتح الجرح وتصريف السوائل المتجمعة
Urinary Tract Infection عدوى المسالك البولية	Germs enter the tube leading to the bladder and cause inflammation and infection. The rate of risk is about 1 in 20. دخول جراثيم في الأنبوب المؤدي إلى المثانة البولية مسبباً التهابات وعدوى. نسبة الخطر 1 من كل 20	Mild cases may clear up without treatment. Usually antibiotics are used to treat the infection. الحالات البسيطة قد تشفى دون علاج. تستخدم عادة المضادات الحيوية لعلاج العدوى.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Possible stoma problems: مشاكل محتملة لفتحة الإخراج		
1. Loss of blood Supply 1. انقطاع التغذية الدموية عنها	1. The blood supply to the stoma may fail and cause damage to the bowel. 1. قد لا يصل الدم للفتحة ويسبب ضرراً للأعضاء	1. This may need further surgery. 1. قد يحتاج جراحة أخرى
2. Stoma Prolapse 2. تدلي الفتحة	2. Stomal prolapse when some of the bowel sticks out too far past the skin 2. يحدث عند التصاق بعض الأمعاء لمسافة طويلة في الجلد	2. For minor prolapses, no treatment is needed. is needed. For more serious cases, more surgery may be needed. 2. الحالات البسيطة لا تحتاج معالجة. الحالات الخطرة قد تتطلب عملية أخرى
3. Parastomal Hernia & Local Skin Irritation فتق بجوار الفتحة & تهيج موضعي للجلد (Stoma is the opening of the bowel onto the skin) (المقصود بالفتحة هي الفتحة التي تفتح فيها الأمعاء على الجلد) (Hernia is the same as a rupture) (الفتق مماثل للتمزق)	3. Parastomal hernia when the bowel pushes through a weak point in the muscle wall and causes pain and bulging of the skin near the stoma. 3. يحدث الفتق حول الفتحة عندما تندفع الأمعاء من خلال جزء ضعيف في جدار العضلة مسببة ألماً و بروزاً منتفخاً للجلد بالقرب من الفتحة 4. Local skin irritation including reddening of the skin and a rash in reaction to the glue used to stick the stoma bag. 4. التهيج الموضعي للجلد يشمل احمرار الجلد مع طفح جلدي كرد فعل تحسسي للغراء المستخدم في تثبيت الكيس	3. Minor hernias may need no treatment. Larger hernias may need more surgery. 3. الفتق البسيط قد لا يستدعي المعالجة. الفتق الكبير قد يحتاج عملية أخرى 4. Changing the type of stomal bag usually treats this. 4. غالباً ما يؤدي تغيير نوع كيس الفتحة لعلاج الأمر
Post operative Bleeding نزيف بعد العملية	Bleeding inside the abdomen. The wound drain may measure this. The risk is about 1 in 35 to 1 in 28. نزيف داخل البطن. أنبوب تصريف الجرح قد تساعد في قياس المشكلة نسبة الخطر من 1 من كل 35 إلى 1 من كل 28	A blood transfusion may be needed to replace lost blood. Sometimes more surgery is needed to stop the bleeding. قد يتطلب الأمر نقل دم لتعويض الفاقد. أحياناً تكون هنا حاجة لإجراء جراحة لإيقاف النزيف

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Damage to the ureter (tube from kidney to bladder) ضرر للحالب (الأنبوب الممتد من الكلية إلى المثانة البولية)	Rarely, during surgery, the ureter, which brings urine from the kidney to the bladder, may be damaged. من النادر أن يحدث خلال الجراحة أن يتضرر الحالب وهو الأنبوب الذي ينقل البول من الكلية إلى المثانة	This may need more surgery. قد يحتاج جراحة أخرى
Bladder may not empty properly or may empty without warning عدم إفراغ المثانة للبول بالشكل الصحيح أو إفراغها للبول دون سابق إنذار	A urinary bladder problem where there is abnormal emptying of the bladder. It may empty without warning or may not empty at all. إحدى مشاكل المثانة البولية والتي يحدث فيها إفراغ غير سليم للبول أو إفراغ دون سابق إنذار أو قد لا يحدث إفراغ مطلقاً	A tube (catheter) into the bladder maybe used to drain the urine away. قد يوضع أنبوب قسطرة بولية في المثانة لتصريف البول
Sexual problems مشاكل جنسية	Men may be unable to get an erection or keep an erection. It may also mean that they cannot ejaculate. In women it may cause pain during or after intercourse. قد يفقد الرجال القدرة على الانتصاب أو الحفاظ على العضو الذكري منتصباً. قد يعني ذلك أيضاً عدم القدرة على القذف. في النساء، قد تشعر المريضة بالألم أثناء أو بعد الجماع	For both men and women, time may improve the condition. Treatment for men may include counseling and medication. For women, counseling and use of water-soluble lubricants during intercourse may help. في الرجال والنساء، قد يتحسن الوضع مع مرور الوقت. العلاج للرجال يشمل الحصول على المشورة وتناول العلاج عند النساء ، يشمل العلاج الحصول على المشورة واستخدام المستحضرات المهبلية المرطبة من النوع الذي يذوب في الماء
The Risk الخطر	What Happens ماذا يحدث	What can be done about it ما يمكن القيام به حيال ذلك
Bowel blockage انسداد الأمعاء	Adhesions (bands of scar tissue) may develop inside the abdomen and the bowel may block. This is a short term and long term complication. الالتصاقات (أحزمة من نسيج متندب) قد تنشأ داخل البطن وقد تنسد الأمعاء. تعتبر هذه من المضاعفات التي تحدث على المدى القصير والبعيد	This may need more surgery. قد تحتاج لجراحة أخرى

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Change in bowel Habits تغيير في سلوك و عادات الأمعاء	Bowel habits will change. Stools may be looser, smaller and more frequent. There may be some leakage of stools particularly at night depending on the type of surgery. سوف يتغير سلوك الأمعاء قد يصبح البراز أكثر رخاوة وأقل كمية ويزداد عدد مرات التبرز. قد يحدث بعض التسرب للبراز خاصة ليلاً، ويتوقف ذلك على نوع الجراحة	In most people, this improves with time, without further treatment. يحدث تحسن مع الوقت لدى معظم المرضى دون الحاجة لأي علاج
Increased risk in Smokers ازدياد المخاطر عند المدخنين	An increased risk of wound infection, chest infection, heart and lung complications and thrombosis. تزداد مخاطر عدوى الجرح، عدوى الصدر، مضاعفات القلب والرئة والتخثرات	Giving up smoking before the operation will help reduce the risk. التوقف عن التدخين قبل الجراحة يقلل من المخاطر

30 day death rate: The rate of risk is about 1 in 63 depending on the type of surgery.
معدل الوفاة خلال 30 يوم : نسبة الخطورة هي 1 من كل 63 ويتوقف ذلك على نوع الجراحة

10. What happens after the procedure? After the operation the nursing staff will closely watch you until you have recovered from the anaesthetic. You may even be cared for in the intensive care unit immediately following your surgery. The recovery period after colon surgery varies. It usually involves a stay in the hospital from 3-10 days in uncomplicated cases. On return from your surgery you will have a catheter (plastic tube) in the bladder to measure and drain your urine.	10. ماذا يحدث بعد الإجراء ؟ بعد الجراحة ، يقوم الفريق التمريضي برعايتك عن قرب حتى تفيق من التخدير. قد تتم رعايتك في العناية المركزة مباشرة بعد الجراحة. تختلف فترة الشفاء التي تعقب جراحات القولون. من المعتاد أن يتطلب ذلك بقاء المريض منوماً في المستشفى لفترة 3-10 أيام في الحالات التي لا تحدث فيها أي مضاعفات أو تعقيدات. عند خروجك من الجراحة ستكون هناك قسطرة بولية (أنبوب بلاستيكي) متصلة بالمثانة البولية لمعرفة كمية البول ولسحبه من المثانة. ستعطى بعد الجراحة محاليل وريدية بواسطة محقنة وقد يتم من خلالها إعطائك مضادات حيوية. تبقى المحقنة الوريدية في
---	---

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

After surgery you will be given intravenous fluids (a drip) through which antibiotics may be given. The drip will remain in place until you are able to drink enough fluids.

Diet

During the first few days of recovery, you will not be able to eat until the bowel has begun to work again. You know the bowel has started to work again when you pass wind and/ or have a bowel movement. You will then begin to take liquids by mouth and then solid food.

If you have a colostomy

The colostomy drains bowel waste from the bowel into the colostomy bag. Most colostomy waste is softer and more liquid than normally passed bowel waste.

The thickness of the bowel waste depends on where the stoma is. You will be taught how to clean around the colostomy and change the colostomy bag.

The colostomy bag sticks to the skin around the stoma with special glue, and can be thrown away when dirty. This bag does not show under clothing, and most people learn to take care of these bags themselves.

Wound

Your wound will have stitches and/ or staples and is usually covered with a dressing, which may be adhesive plaster or a spray-on plastic covering.

Drain

You may also have a small tube that drains into a bag or a bottle from near your wound. This is called a drain. The wound drain removes fluid from your wound and helps in the healing process. It is taken out when the drainage has dried up.

Your lungs and blood supply

It is likely that on your return from surgery you

موضعها حين تتمكنك من شرب كميات كافية من السوائل .

التغذية

خلال الأيام الأولى بعد العملية سوف لن تتمكن من تناول الطعام حين عودة الأمعاء للعمل من جديد. تعرف أن الأمعاء قد عادت للعمل عندما تلاحظ خروج غازات و/ أو تشعر بحركة الأمعاء. عند حدوث ذلك، تبدأ في تناول السوائل عبر الفم ثم بعد ذلك تبدأ في تناول الأطعمة الصلبة.

إذا كانت لديك فتحة فغر القولون الخارجية لإخراج الفضلات: تنقل هذه الفتحة الفضلات من الأمعاء إلى كيس الفتحة. في معظم الحالات ، تكون الفضلات الخارجة عن طريق هذه الفتحة أكثر ليونة وسيولة من البراز الطبيعي. سماكة فضلات الأمعاء تتوقف على موقع الفتحة. سيتم تدريبك على كيفية الحفاظ على نظافة منطقة الفتحة وتغيير الكيس. يلتصق كيس الفتحة بالجلد حول الفتحة بواسطة غراء من نوع خاص ويمكن التخلص من الكيس إذا كان متسخاً. لا يظهر الكيس من تحت الملابس، ويتعلم غالبية المرضى كيف يعتنون بالكيس بأنفسهم.

الجرح

سوف يحتوي الجرح لديك على خيوط جراحية و / أو دبابيس جراحية ويكون في الأغلب مغطى بالضمادات (الغيارات) والتي قد تكون ضمادات لاصقة أو مادة بلاستيكية ترش من خلال بخاخ.

أنبوب تصريف السوائل

قد يوجد أيضاً بالقرب من الجرح أنبوب صغير يصرف السوائل إلى كيس أو زجاجة ، ويسمى هذا أنبوب تصريف سائل الجرح ، ويقوم بتصريف سائل الجرح والمساعدة على التئامه ، وتتم إزالته بعد أن يصبح الأنبوب جافاً.

رئتك وإمدادات الدم

من الأرجح أن تخرج من العمليات وأنت ترتدي جوارب مرنة

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

will be wearing elastic (anti- embolism) stockings. These are tight fitting stockings that are used to reduce the risk of blood clots forming in your legs.

It is very important after surgery that you start moving as soon as possible. This helps to prevent blood clots forming in your legs and possibly going to your lungs. This can be fatal.

Also, you need to do your deep breathing exercises. Take ten deep breaths every hour to prevent secretions in the lungs from collecting. If this happens, you may develop a chest infection. At all costs, avoid smoking after surgery as this increases your risk of chest infection. Coughing is painful after abdominal surgery

Exercise

Expect to feel tired for some time after surgery. You need to take things easy and gradually return to normal duties, as you feel able to. It usually takes at least 6 months to get over the operation. You should not drive during the first 2-3 weeks. Do not lift heavy weights for at least six weeks after surgery. This is to prevent a rupture where the cuts were made and allow healing to take place inside.

11. Tell your doctor if you have:

- Large amounts of bloody leakage from the wound.
- Blood in the stool.
- Fever and chills.
- Pain that is not relieved by prescribed pain killers.
- Swollen abdomen.
- Swelling, tenderness, redness at or around the cut.

ضيقة تمنع انسداد الأوعية الدموية للتقليل من مخاطر تكون تخثرات دموية في الساقين.

من المهم بعد إجراء الجراحة أن تبدأ وفي أقصر وقت ممكن بالحركة. يساعد ذلك على منع تكون التخثرات في ساقيك واحتمال وصولها إلى رئتيك. حدوث مثل هذا الأمر قد يكون مميتاً. كما أن عليك القيام بتمارين التنفس العميق الخاصة بك. قم بأخذ عشرة (10) أنفاس عميقة كل ساعة لمنع تجمع الإفرازات في الرئة لأن حدوث ذلك قد يسبب لك التهاباً وعدوى في الصدر. في كل الأحوال ومهما كان الثمن ، فإن عليك تجنب التدخين بعد الجراحة لأن ذلك يزيد من مخاطر إصابتك بعدوى والتهاب الصدر. يكون السعال مؤلماً بعد العملية الجراحية في البطن.

ممارسة التمارين الرياضية
توقع أن تشعر بالتعب بعد العملية الجراحية.
خذ الأمور بهدوء و روية . عد إلى القيام بواجباتك ونشاطاتك بشكل تدريجي كلما شعرت بقدرتك على ذلك. من المعتاد أن يتجاوز المريض كل تبعات الجراحة في غضون ستة أشهر.
لا يجب عليك قيادة المركبات خلال أول أسبوعين أو ثلاثة بعد الجراحة.
لا تقم بحمل أوزاناً ثقيلة لستة أسابيع على الأقل بعد الجراحة . يمنع ذلك حدوث تمزق في المناطق التي خضعت للجراحة ، كما يساعد عملية التئام الجروح الداخلية.

11. قم بإبلاغ طبيبك عند ملاحظتك الأمور التالية:
• خروج كميات كبيرة من السوائل المختلطة بالدم من الجرح

- وجود دم في البراز
- ارتفاع في درجة الحرارة مع قشعريرة
- ألم لا يختفي بالرغم من تناول أدوية الألم الموصوفة
- تورم وانتفاخ في البطن
- تورم واحمرار حول الجرح وشعور بالألم عند ملامسة ما حول الجرح